PROTOCOLLO 36

Mobilizzazione in posizione seduta

Alternativa alla posizione supina per pazienti con fastidio cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Paziente che non tollera la posizione supina
- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Verifica funzionale in posizione eretta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, capo appoggiato al torace del terapista.

Fisioterapista: dietro al paziente, guanto monouso.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto con il capo appoggiato al torace del terapista.



Stabilizzazione
Il terapista stabilizza il cranio con il proprio corpo.



Presa
Pollice intraorale sui molari inferiori.



Tecnica
Distrazione e scivolamento come in posizione supina.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I a III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Garantisci un buon appoggio del capo
- ✓ Controlla la postura cervicale
- ✓ Comunica costantemente

Errori da evitare

- ! Capo non stabilizzato
- ! Postura scorretta del terapista
- ! Forza in direzione errata

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura seduta	Aperture lente con postura corretta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La posizione seduta rende la tecnica più funzionale e confortevole per alcuni pazienti.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.